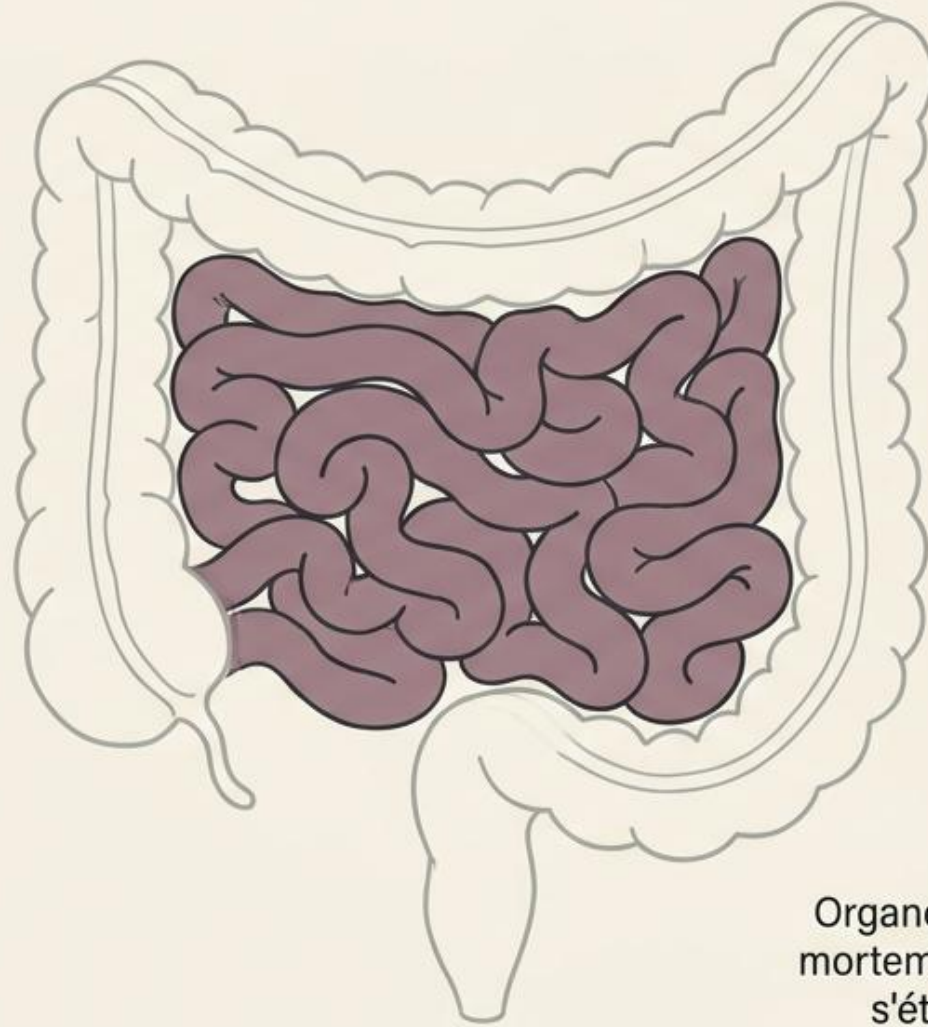


L'Intestin Grêle : Anatomie, Écosystème et Approche ROP

Chapitre 14 — Le carrefour systémique, mécanique, neurologique et immunitaire.



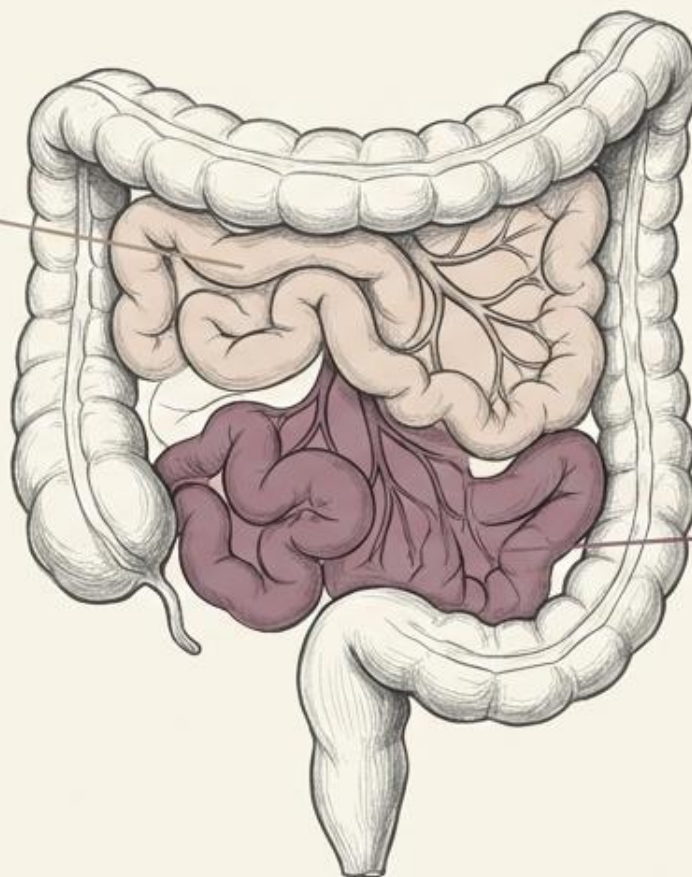
Organe le plus long du corps (6 à 7 mètres post-mortem, rétracté in vivo par le tonus musculaire), s'étendant du pylore à la valvule iléo-cæcale.

Topographie : L'intestin grêle au sein du cadre colique

Le **jéjunum-iléum** (6 à 7 mètres sur le cadavre) comporte 15 à 16 anses intestinales réparties en deux groupes fonctionnels distincts.

Jéjunum

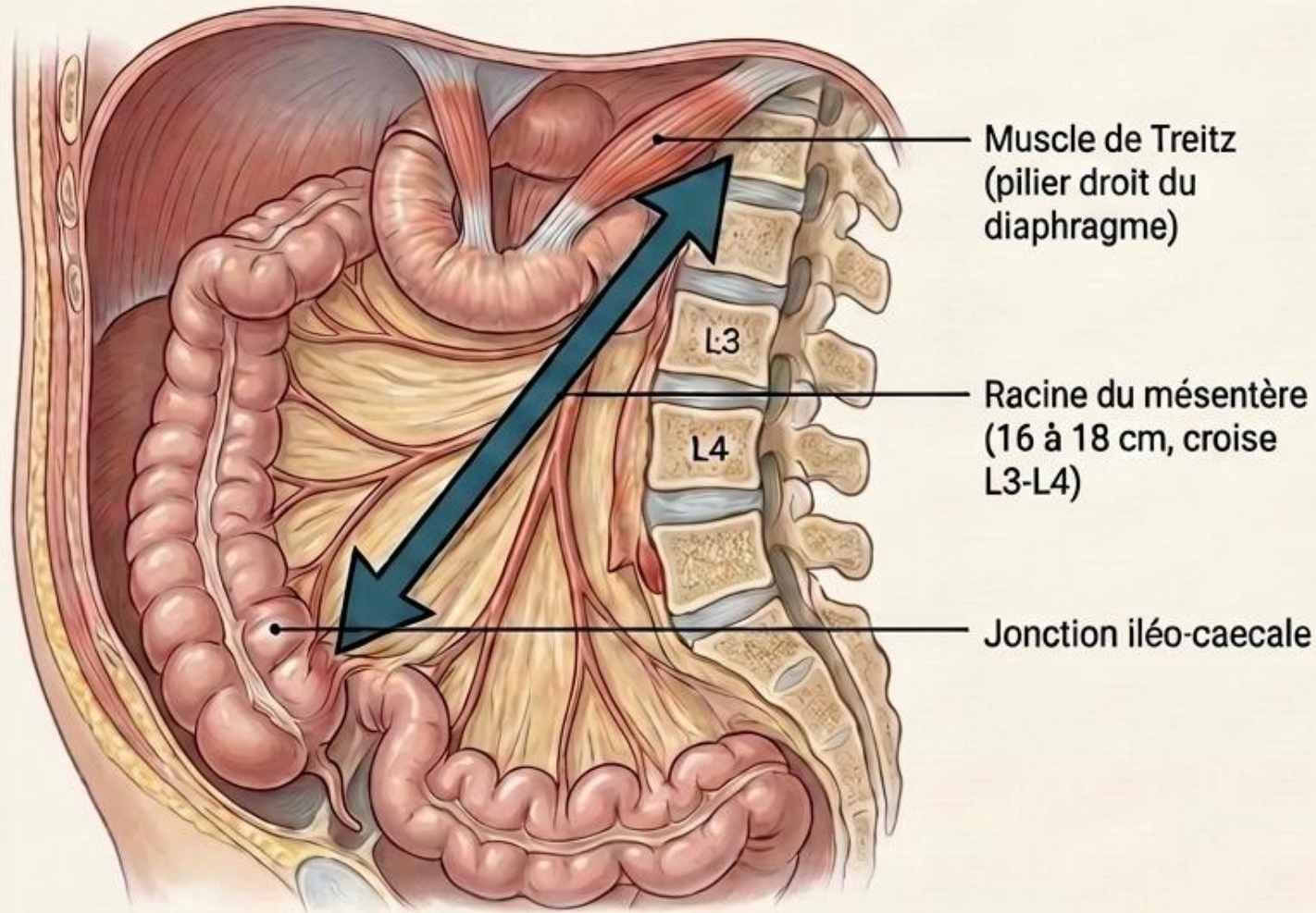
- **Localisation** : Quadrant supérieur gauche.
- **Orientation** : Anses et système vasculaire orientés horizontalement.
- **Rapports** : Recouvre le côlon descendant.
- **Caractéristiques** : Groupe généralement plus développé.



Iléum

- **Localisation** : Quadrant inférieur droit.
- **Orientation** : Anses et système vasculaire orientés verticalement.
- **Rapports** : Laisse libre le côlon ascendant.

Le mésentère et sa mécanique de suspension

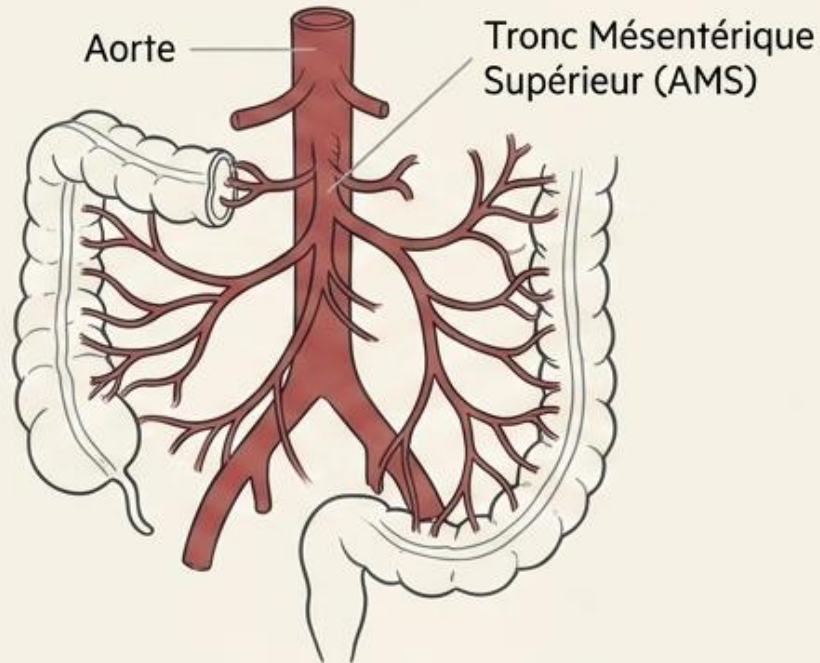


Intérêt en ROP (Nutcracker Syndrome)

- Une **diminution** de la tension longitudinale de la racine du mésentère peut favoriser une **compression aorto-mésentérique** : compression de la 4e portion du duodénum et/ou de la veine rénale gauche entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure
- **Conséquence clinique** : retard d'évacuation du contenu duodénal et reflux gastro-duodénal.

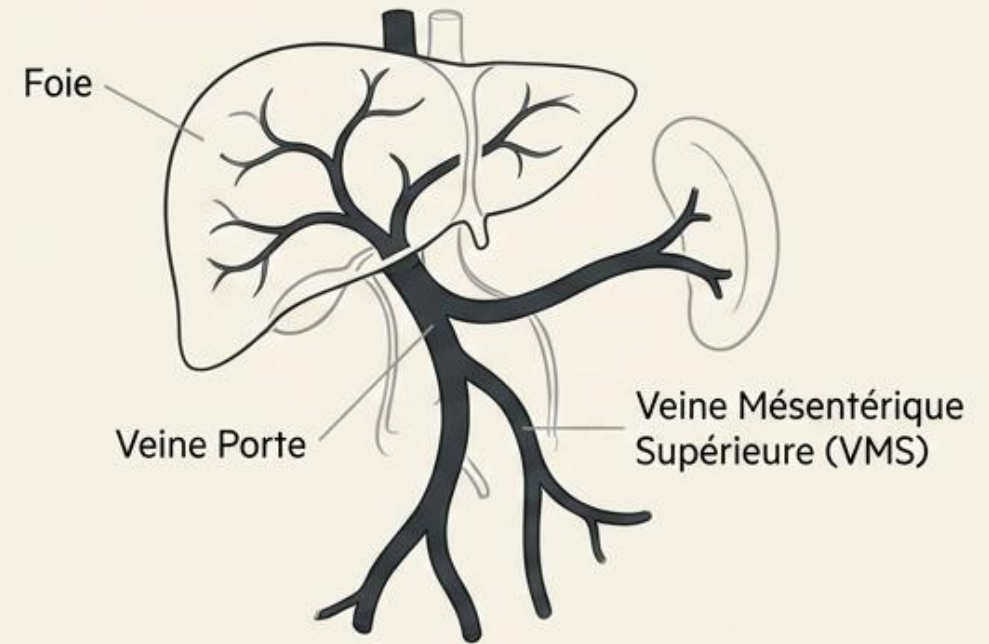
Le mésentère est un repli à double feuillet du péritoine reliant l'intestin grêle à la paroi abdominale postérieure ; il contient les vaisseaux sanguins, les vaisseaux lymphatiques et les nerfs destinés à l'intestin

L'axe de l'irrigation et du drainage : Tronc Mésentérique Supérieur



Apport Artériel (Artère mésentérique supérieure)

- Origine : Disque Th12-L1 (sous le tronc cœliaque)
- Irrigue l'intestin grêle, le côlon ascendant et les 2/3 proximaux du transverse



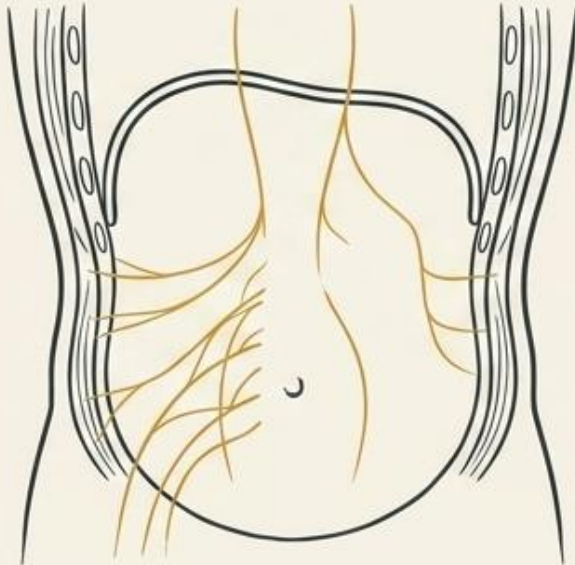
Drainage Veineux (Système Porte)

- Transporte le sang veineux chargé des nutriments absorbés directement vers le foie pour détoxification et métabolisation.

Note Pratique : Le pouls de l'AMS est perceptible au niveau du 3ème duodénum, à droite de l'ombilic.

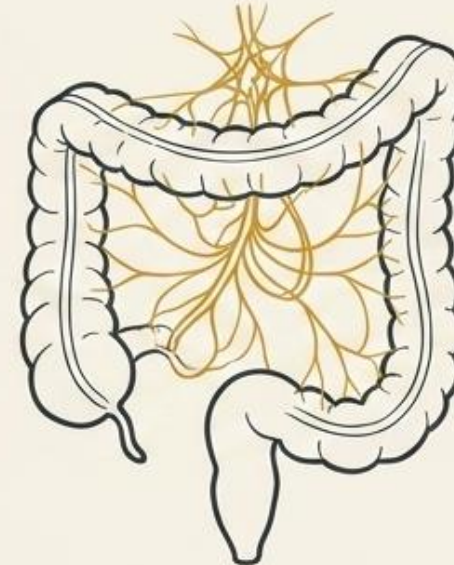
La double réalité neurologique du péritoine

Péritoine Pariétal (Innervation Somatique)



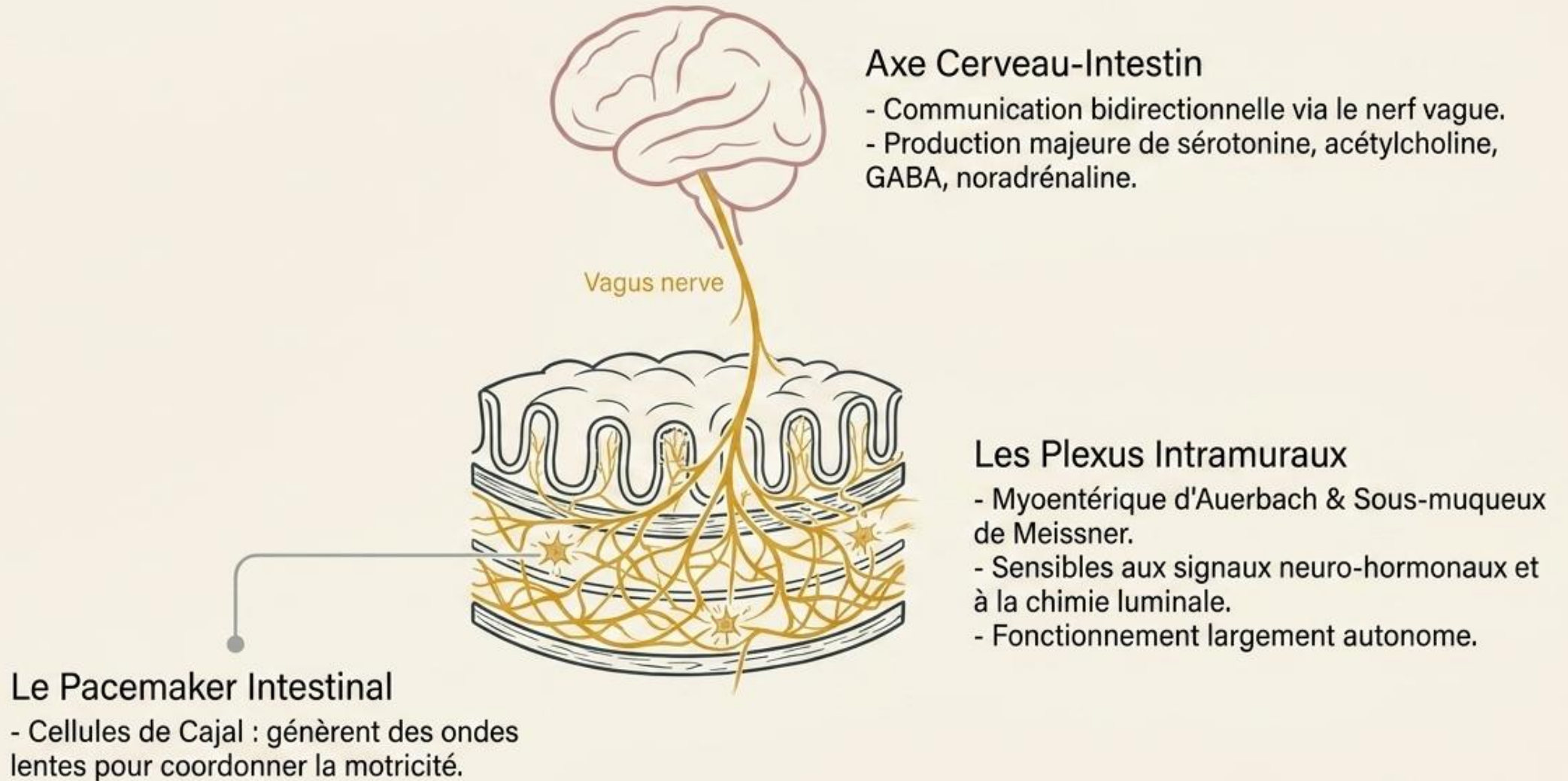
- Voies : Nerfs phréniques, 6 derniers intercostaux, plexus lombaire.
- Sensibilité : Aiguë (douleur, pression, température).
- Implication ROP : Projection des douleurs péritonéales vers le système ostéo-musculo-articulaire (cervicales, lombaires, scapulaires).

Péritoine Viscéral (Innervation Autonome)



- Voies : Système Sympathique (Th8-Th11, nerfs splanchniques) et Parasympathique (Nerf Vague).
- Sensibilité : Faible au toucher/section. Stimulée par l'étirement (distension) et la chimie.
- Implication ROP : Le Sympathique inhibe le péristaltisme (stress) ; le Vague le favorise.

Le Deuxième Cerveau : Autonomie du Système Nerveux Entérique (SNE)



Le "Deuxième Cerveau" : Système Nerveux Entérique

Plexus Intra-Muraux

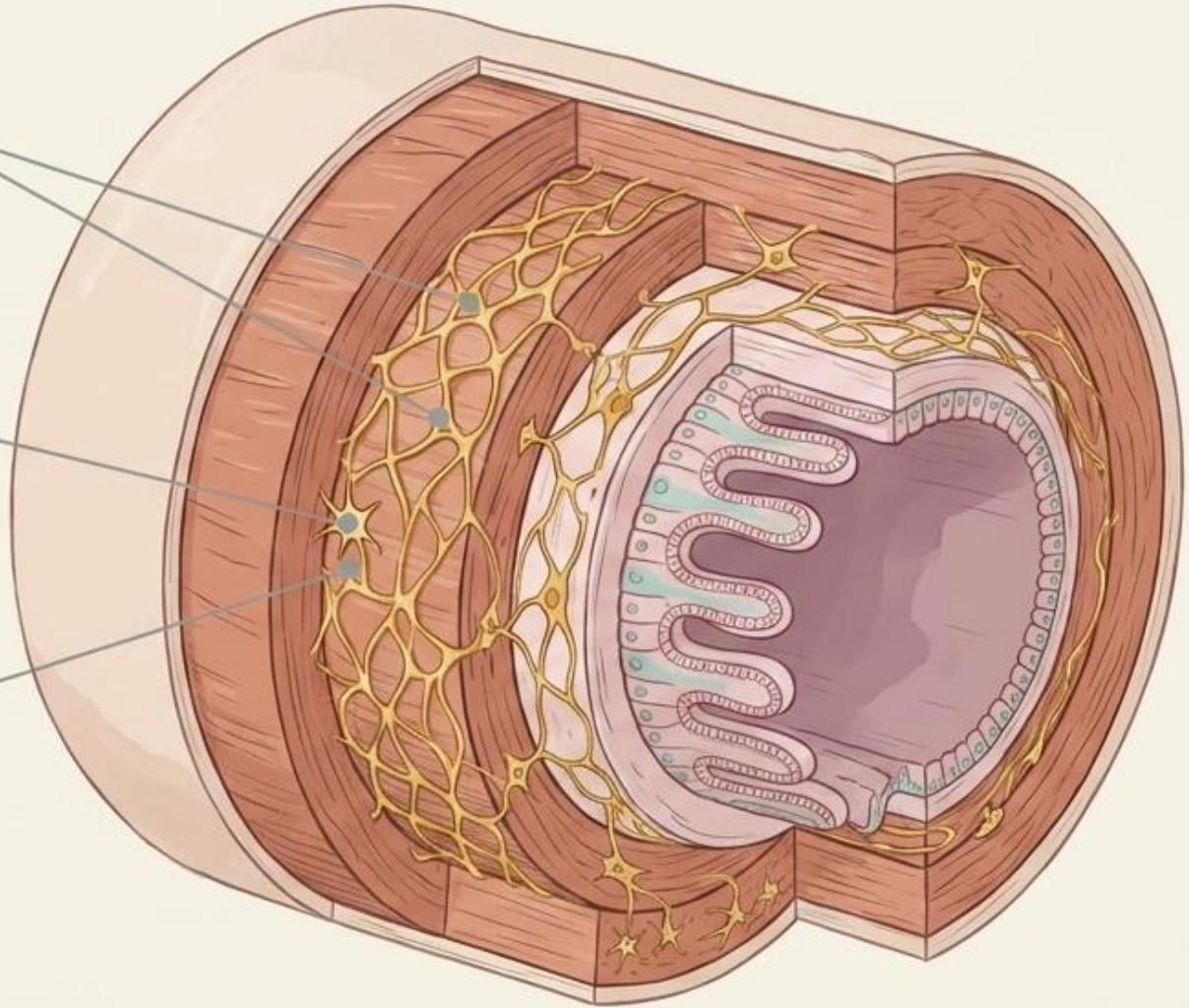
Plexus myentérique d'Auerbach et sous-muqueux de Meissner. Assurent une régulation quasi autonome des fonctions digestives.

Cellules de Cajal

Le pacemaker intestinal. Génèrent des ondes lentes qui coordonnent la motricité indépendamment du péristaltisme induit par le chyme.

Production Neurochimique

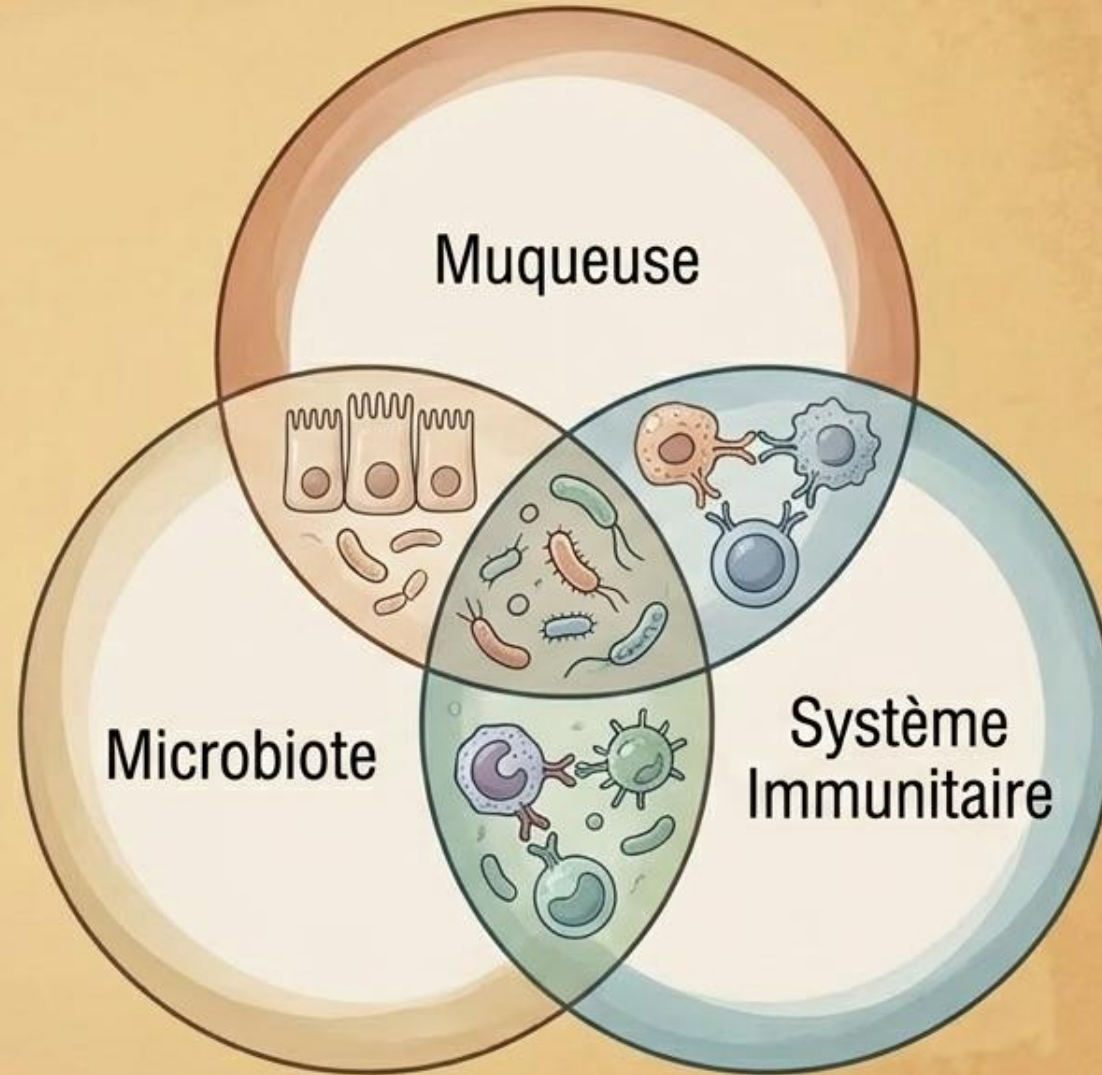
Synthèse majeure de sérotonine (régulation de l'humeur partagée avec le cerveau), d'acétylcholine, de noradrénaline et de GABA.



L'Écosystème Intestinal : Symbiose et Immunité

Le Microbiote (La Flore) :

- Environ 38 milliards de bactéries.
- Une signature unique par individu, colonisée dès la naissance.
- Relation commensale/symbiotique indispensable à la digestion et à l'immunité.



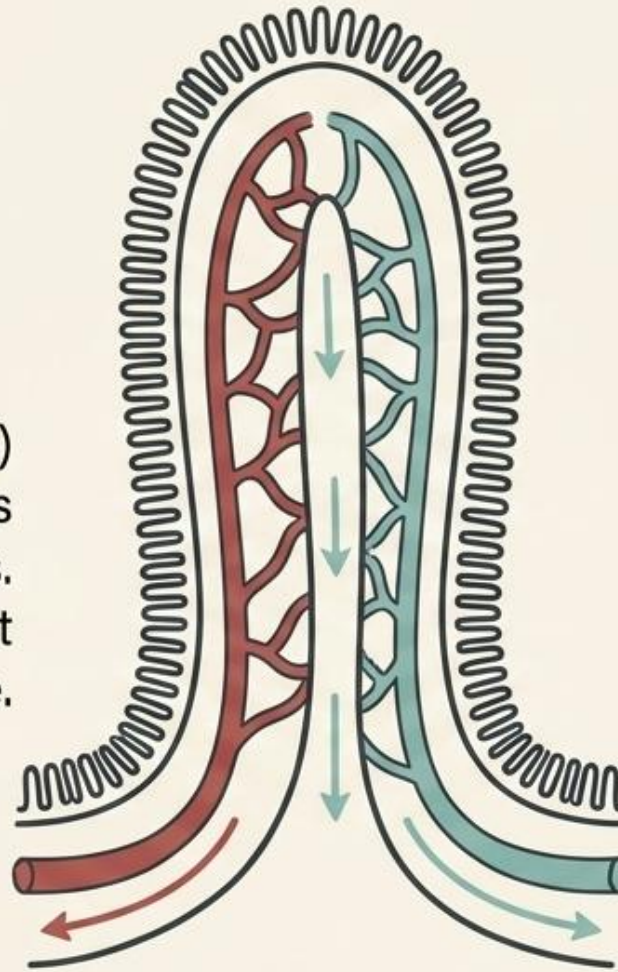
L'Immunité (GALT) :

- Gut Associated Lymphoid Tissue : Tapisse la muqueuse (inclut les plaques de Peyer).
- Mastocytes & Cellules de Paneth : Libèrent des peptides antimicrobiens.
- Charge microbienne maintenue bien inférieure à celle du côlon en conditions saines.

La Double Voie d'Absorption Micronutritionnelle

Voie Sanguine (Capillaires)

- Absorbés : Eau, oses simples, acides aminés, vitamines hydrosolubles.
- Destination : Acheminés directement vers le foie via le système porte.



Voie Lymphatique (Chylifères)

- Absorbés : Graisses, protéines à chaîne longue, vitamines liposolubles (A, D, E, K).
- Destination : Réseau lymphatique -> Citerne de Pecquet -> Canal thoracique.



Intérêt en ROP : Une action réflexe podale sur le foie et le système lymphatique soutient qualitativement l'absorption et l'immunité.

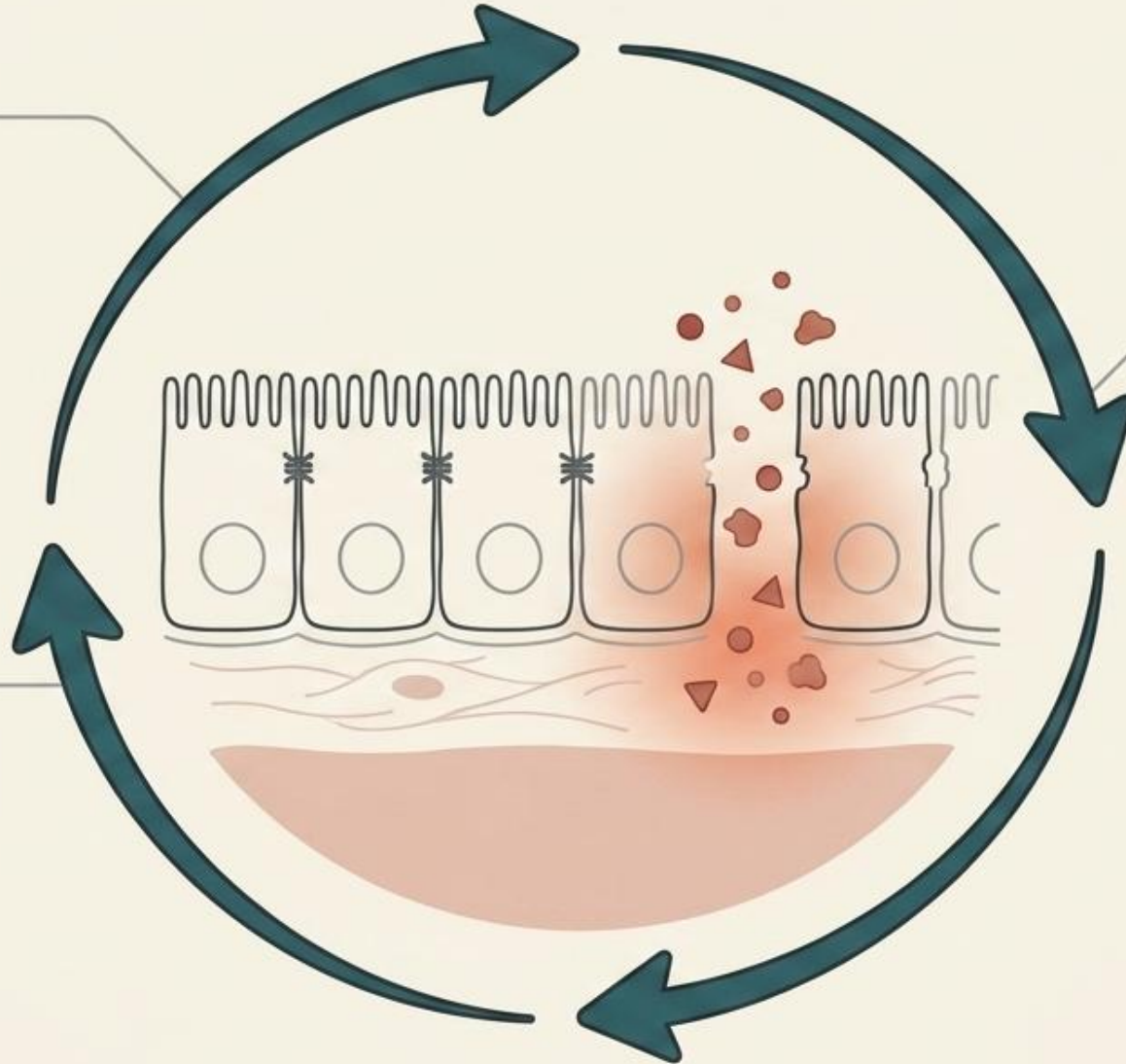
La Spirale : Dysbiose et Hyperperméabilité

Déclencheurs

Stress chronique (vasoconstriction sympathique), aliments ultra-transformés, AINS, antibiotiques.

Hyperperméabilité

Altération des jonctions serrées. Passage de toxines et protéines incomplètement dégradées, déclenchant l'inflammation.

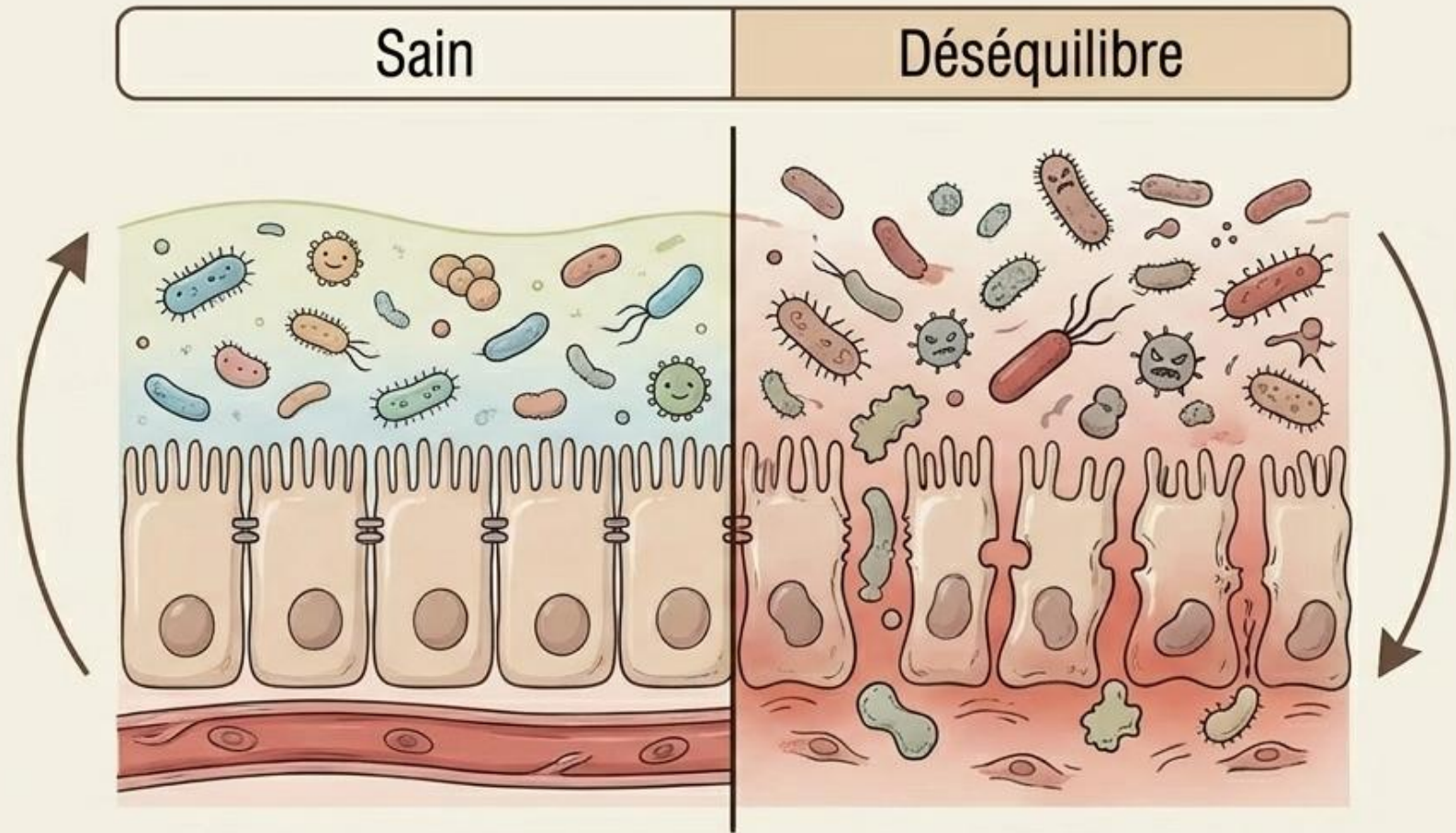


Conséquences Systémiques

Surcharge hépatique (théorie de l'engrassement de Seignalet). Le foie saturé redirige les déchets vers les tissus, provoquant douleurs ostéo-articulaires, tendineuses et allergies.

Déséquilibre : Hyperperméabilité et Dysbiose

Le Cercle Vicieux : L'altération des jonctions serrées (Leaky Gut) et la perturbation du microbiote (Dysbiose) s'entretiennent mutuellement, passant d'une fermentation physiologique à une putréfaction anormale.



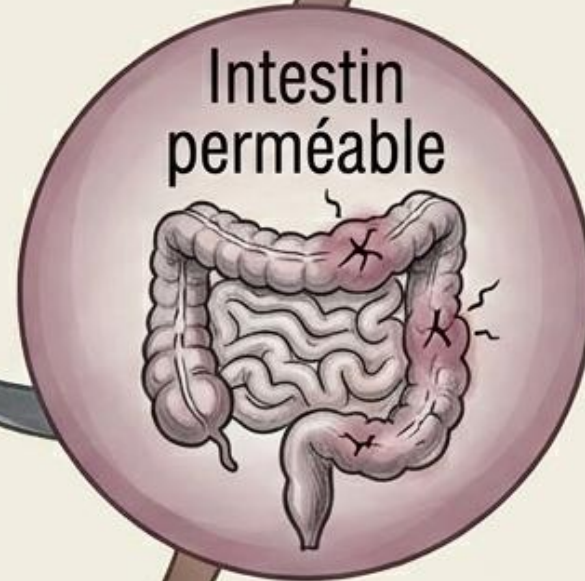
Facteurs Déclencheurs :

- Stress chronique : Activation sympathique modifiant la perfusion sanguine.
- Médicaments : AINS, antibiotiques, corticoïdes.
- Hygiène de vie : Alimentation ultra-transformée, sucres, sport d'endurance extrême (vol de sang splanchnique).
- Biomécanique (ROP) : Fixations vertébrales, fibroses des attaches péritonéales.

Les Conséquences Systémiques du Terrain Inflammatoire

Dérèglement Immunitaire :
Exposition anormale du
système aux antigènes
alimentaires -> allergies,
hypersensibilité (histamine).

Douleurs Ostéo-Musculaires :
Lombalgies, arthralgies,
fibromyalgie (théorie de
l'encrassement tissulaire).



Surcharge Hépatique :
Le passage portal accru
de toxines majeure le travail
de détoxification du foie.



Pathologies Associées :
Asthme, sinusites, cystite,
maladies auto-immunes
(facteur associé).

L'œil ROP : Devant des douleurs articulaires sans traumatisme évident, rechercher l'implication viscérale.

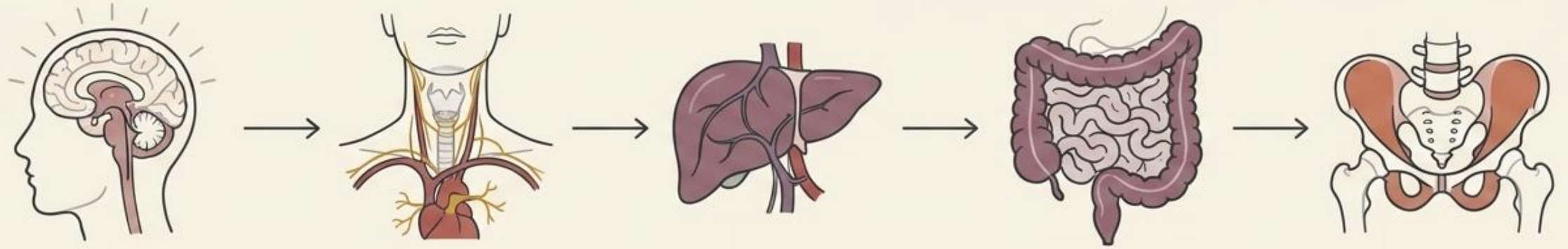
Signes d'Alerte et Diagnostic d'Exclusion

Orientation Médicale Impérative en présence de :

- - Fièvre, sang rouge ou noir dans les selles.
- - Perte de poids importante et inexpliquée.
- - Ganglion de Troisier (carrefour jugulo-subclavier gauche) : suspicion oncologique.
- - Signe du glaçon : évocateur d'une ascite.
- - Hernie inguinale étranglée irréductible.
- - Occlusion / Iléus : Arrêt des matières et gaz. Peut être mécanique (tumeur, bride) ou paralytique (atonie par irritation péritonéale).

Protocole ROP : Ordre de Traitement

Aborder le terrain avant le symptôme local.



**Étape 1 : MRP
& Cerveau**
(Diencephale, Tronc
cérébral).

Étape 2 :
Système S.N.A.
(Équilibration du Nerve
Vague).

**Étape 3 : Foie
& Drainage**
(Soutien du métabolisme
et système porte).

**Étape 4 : Intestin
Grêle & Côlon**
(Motricité, anses jéjuno-
iléales, mésentère).

Étape 5 :
Ostéo-Articulaire
(Bassin, sacro-iliaques,
colonne).

Objectif

Soutenir les capacités de régulation du terrain sans se substituer au suivi médical allopathique.
Progression douce requise.

Synthèse d'Intervention ROP : Protocole Intestin Grêle

Step 1: Écoute et Induction (Système Limbique)

Action : Un pouce sur la zone Intestin Grêle, l'autre sur la zone Cerveau Limbique.

Objectif : Apaiser la charge viscéro-émotionnelle (stress, anxiété, besoin de sécurité) et relancer le tonus vagal.



Step 2: Libération Structurale (Relations Viscéro-Somatiques)

Action : Traitement des fixations vertébrales et costales.

Zones cibles : Charnière Th10-Th12 (Sympathique) et L1-L2 (Plexus lombaire, racine du mésentère).



Step 3: Traitement Locorégional (Viscéral)

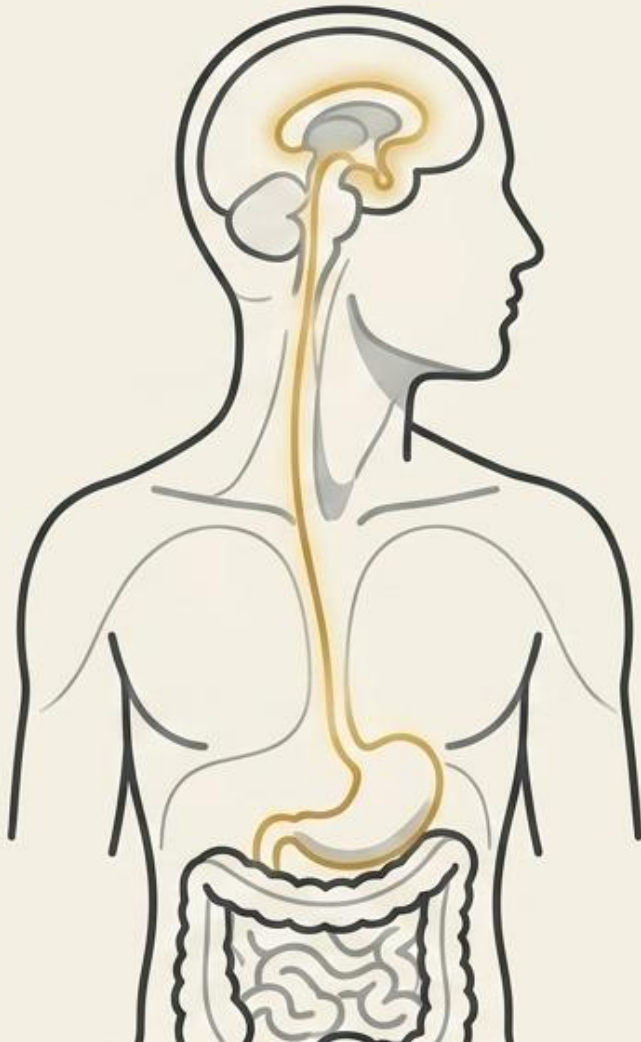
Action : Levée des tensions de suspension et stimulation du péristaltisme.

Zones cibles : Diaphragme (Treitz), Estomac (réflexe), Racine du mésentère (tension longitudinale), et cartographie Jéjunum/Iléum.

L'approche ROP restaure la mobilité, l'innervation et l'écosystème : une réponse globale à la maxime 'Toute maladie commence dans l'intestin'

Profil Viscéro-Émotionnel : La 'Personne Intestin'

La muqueuse est lue en ROP comme un récepteur-émetteur d'émotions.



Signes Physiques

- Fatigue matinale
- Douleurs lombaires / genoux
- Troubles du transit
- Hypersensibilité aux fixations ostéo-musculaires

Traits Émotionnels

- Besoin viscéral de sécurité et de repères fixes.
- Hyperprotectrice envers les siens, méticuleuse.
- Anxiété souvent masquée par une assurance de façade ou de la logorrhée.
- Humeur changeante, facilement contrariée.